

## Ramowy Plan Wdrożenia Innowacji

# Organizator kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania

**Autor innowacji:** Centrum Opieki Domowej S.C.: Zuzanna Mysłowska, Beata Mróz

### 1. Istota innowacji:

Innowacja to model wsparcia dla osób starszych i niesamodzielnych, które po hospitalizacji wracają do domu bez odpowiedniego przygotowania systemowego i rodzinnego. Jej sercem jest rola koordynatora w postaci pielęgniarki opieki długoterminowej, która w ciągu 24 godzin od zgłoszenia dociera do pacjenta, by ocenić jego potrzeby i przygotować rodzinę do zapewnienia wsparcia.

### 2. Kluczowe wyróżniki rozwiązania

- **Natychmiastowość działania:** Wsparcie jest udzielane w krytycznym momencie – pierwsza wizyta odbywa się w pierwszej dobie po wypisie ze szpitala.
- **Charakter koordynacyjny:** Rozwiązanie nie tworzy nowej usługi medycznej, lecz łączy istniejące zasoby (szpitale, POZ, pomoc społeczna) w spójną sieć pomocy.
- **Wsparcie bezpośrednio w domu:** Pomoc dociera tam, gdzie potrzeby są największe, eliminując rozproszenie informacji.
- **Edukacja opiekunów naturalnych:** Innowacja skupia się na przekazaniu praktycznej wiedzy rodzinie, co redukuje ich lęk i zwiększa kompetencje opiekunów.

### 3. Diagnoza: na jaki problem/potrzebę odpowiada innowacja?

W systemie opieki występuje **krytyczna luka organizacyjna** dotycząca wsparcia pacjentów bezpośrednio po opuszczeniu szpitala.

- **Długi czas oczekiwania:** Na objęcie opieką długoterminową w warunkach domowych czeka się od 4 do 6 miesięcy, a w tym czasie pacjent pozostaje bez profesjonalnego wsparcia.

- **Nieprzygotowanie rodzin:** Rodziny często nie dysponują wiedzą ani umiejętnościami niezbędnymi do opieki nad osobą obłożnie chorą, co prowadzi do frustracji i błędów pielęgnacyjnych.
- **Ryzyko powikłań i rehospitalizacji:** Brak szybkiej interwencji skutkuje szeregiem konsekwencji, takich jak odleżyny, infekcje czy szybki powrót pacjentów do szpitali, co generuje dodatkowe koszty systemowe.
- **Fragmentaryczność informacji:** Pomoc jest rozproszona między lekarzy, pracowników socjalnych i pielęgniarzy, przez co rodzina czuje się zagubiona w gąszczu procedur. Informacje przekazywane podczas wypisu są fragmentaryczne, przekazywane językiem specjalistycznym i obejmują wiele zadań, które trzeba wykonać w krótkim czasie.

#### 4. Model Innowacji: Co konkretnie wdrażasz?

Innowacja opiera się na **gotowym zestawie narzędzi i procedur**, które umożliwiają płynne przejście pacjenta ze szpitala do domu:

- **Rola Organizatora:** Przeszkolona pielęgniarka opieki długoterminowej pełniąc funkcję mobilnego koordynatora.
- Narzędzia diagnostyczne i operacyjne:
  - Kwestionariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego (KIWP).
  - Karta wsparcia pacjenta (KWP) i Karta wizyt weryfikująco-wspierających (KWWW).
  - Procedura interwencji w ciągu 24h od wypisu.
- **Pakiety Edukacyjne (Broszury):** Specjalistyczne instruktaże dla opiekunów dotyczące m.in. pielęgnacji ciała, rany przewlekłej, opieki w cukrzycy, chorobie Parkinsona czy po udarze mózgu.
- **Konspekty szkoleń:** Materiały przygotowujące kadrę medyczną do pełnienia nowej roli.
- **Etapy działania:**
  - Inicjacja - kontakt w 24 h
    - Telefon do pacjenta/rodziny lub szpitala w celu umówienia wizyty i wstępnego rozpoznania potrzeb.
  - Interwencja - pierwsza wizyta domowa (3,5 h)
    - Szczegółowa diagnoza i wypełnienie Karty Wsparcia Pacjenta.
    - Trening opiekuńczy (karmienie, higiena, leki).

- Doradztwo sprzętowe i ergonomizacja mieszkania.
- Edukacja rodziny i przekazanie broszur.
- Koordynacja usług i zapewnienie kontaktu telefonicznego z pielęgniarką.
- Weryfikacja i wsparcie - dwie wizyty w przeciągu 2 tygodni (każda 2 h)
  - Ocena realizacji zaleceń, ewentualna modyfikacja planu, wsparcie psychiczne i merytoryczne, dokumentacja postępów.

## 5. Lekcje z testowania: Jak unikać pułapek?

Ponad półroczne testowanie modelu na grupie 7 pacjentów w wieku 76-99 lat pozwoliło wyciągnąć kluczowe wnioski:

- **Pierwsza wizyta jest kluczowa** – musi trwać odpowiednio długo (ok. 3,5 godz.), aby rzetelnie przeprowadzić diagnozę bio-psycho-społeczną, na podstawie której możliwe będzie opracowanie indywidualnego planu działania.
- **Współpraca ze szpitalem** – niezbędne jest zawarcie jasnej umowy określającej zasady kierowania pacjentów do modelu, aby unikać przestojów w komunikacji.
- **Indywidualizacja wsparcia** – problemy rodzin są różnorodne (od diety po brak wsparcia dalszej rodziny), dlatego plan działania musi być elastyczny i korygowany podczas wizyt weryfikujących.
- **Budowanie poczucia bezpieczeństwa** – sam fakt dostępności koordynatora pod telefonem i szybka wizyta w domu znacząco redukują lęk u opiekunów.

## 6. Matryca logiczna

|  <b>Problem</b>                |  <b>Rozwiązanie</b>                                                                                                                          |  <b>Cel główny</b>                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krytyczna luka organizacyjna i brak wsparcia dla pacjentów oraz ich rodzin bezpośrednio po wypisie ze szpitala. | Wprowadzenie modelu łączącego istniejące zasoby (szpital, POZ, OPS/CUS), w celu zapewnienia mobilnego wsparcia w ciągu 24 godzin od zgłoszenia oraz stworzenia indywidualnego plan działania w miejscu zamieszkania pacjenta. | Wdrożenie modelu jako skutecznej usługi społecznej, zapewniającej bezpieczeństwo osobom starszym i niesamodzielnym oraz ich opiekunom w kluczowym momencie przejścia między hospitalizacją a opieką domową. |

## 7. Strategia Komunikacji i BIG IDEA

Komunikacja innowacji powinna budować wizerunek „bezpiecznego pomostu” między szpitalem a domem:

„Bezpieczny powrót do domu – wsparcie od pierwszej doby”.

- **Filary przekazu:** Pokazanie luki w systemie, prezentacja modelu szybkiej interwencji oraz dowody skuteczności (zmniejszenie liczby rehospitalizacji).
- **Ton:** Towarzyszący, wspierający, partnerski i pozbawiony specjalistycznego żargonu.
- **Grupy docelowe:** Personel medyczny (szpitale, POZ), rodziny pacjentów i opiekunowie oraz instytucje wdrożeniowe (instytucje pomocy społecznej, samorządy, organizacje pozarządowe). Również osoby niesamodzielne i przewlekłe chore, które mogą skorzystać z modelu.

## 8. Potencjał rozwoju i inspiracje

Wnioskodawcy mogą skalować rozwiązanie, włączając je do regionalnych polityk zdrowotnych. Model może być wprowadzany początkowo w pojedynczych jednostkach – np. w jednym szpitalu, ośrodku pomocy społecznej lub organizacji pozarządowej – ponieważ nie wymaga rozbudowanej infrastruktury, a jedynie przeszkolenia personelu i wdrożenia standardów

pracy. W miarę zdobywania doświadczeń model może być rozszerzany na kolejne placówki i gminy.

- **Inspiracje krajowe:** Projekt **Małopolski Tele-Anioł** (szybka reakcja) oraz programy Fundacji Hospicyjnej dla opiekunów rodzinnych.
- **Inspiracje światowe:** Holenderski model **Buurtzorg** (zespoły pielęgniarские w środowisku pacjenta) oraz brytyjski system **NHS Discharge to Assess**, gdzie ocena potrzeb odbywa się dopiero w domu pacjenta.

## 9. Podsumowanie korzyści dla realizatora (np. Gminy, POZ, OPS/CUS, NGO):

Korzystanie z innowacji „Organizator kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania” zapewnia pacjentom **płynne przejście z opieki szpitalnej do domowej** dzięki szybkiej interwencji pielęgniarki, indywidualnie dobranym działaniom i skutecznej profilaktyce powikłań, co zmniejsza ryzyko rehospitalizacji, redukuje cierpienie i pozwala dłużej pozostać w środowisku domowym.

Rodziny otrzymują **praktyczne szkolenie, wsparcie emocjonalne, jasne instrukcje** dotyczące dostosowania mieszkania oraz uporządkowanie informacji o dostępnych formach pomocy, co zwiększa ich kompetencje, poczucie bezpieczeństwa i stabilizuje życie codzienne.

Dla systemu opieki model oznacza **realne oszczędności finansowe, większą efektywność organizacyjną i szybszą odpowiedź na potrzeby**, których standardowe usługi publiczne nie są w stanie zaspokoić w tak krótkim czasie po wypisie ze szpitala. Wdrożenie innowacji pozwala na **realną poprawę jakości opieki** bez konieczności tworzenia nowych instytucji, a realizator zyskuje **efektywność ekonomiczną** dzięki ograniczeniu niepotrzebnych rehospitalizacji i powikłań, **lepszą koordynację** wynikającą z usprawnienia przepływu informacji między sektorem medycznym a społecznym oraz **wizerunek nowoczesnej, odpowiedzialnej instytucji**, która realnie wspiera najstarszych członków lokalnej społeczności i ich rodziny.

# Organizator kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania

### 1. Istota innowacji - czego nie można zgubić

Organizator kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania nie jest nową usługą medyczną, dodatkową pielęgniarką ani "telefonem informacyjnym po wypisie". To szybki, domowy mechanizm przejęcia pacjenta i rodziny w krytycznym momencie: po wyjściu ze szpitala, zanim system opieki długoterminowej, POZ, rodzina i pomoc społeczna zdążą realnie zadziałać.

Istotą innowacji jest pierwsza interwencja w domu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, przeprowadzona przez przygotowaną osobę koordynującą, która:

- ocenia sytuację pacjenta i rodziny,
- uczy rodzinę podstaw opieki,
- pomaga uporządkować pierwsze dni po wypisie,
- łączy dostępne zasoby: szpital, POZ, OPS/CUS, rodzinę i lokalne usługi.

To bardzo ważne: problemem po hospitalizacji często nie jest wyłącznie brak usług, ale chaos informacyjny i rozproszenie odpowiedzialności. Rodzina dostaje wiele zaleceń medycznych, dokumentów i informacji naraz, ale nie wie: co zrobić dziś, co jest najważniejsze, gdzie zadzwonić, jakie wsparcie można uruchomić lokalnie.

Tego nie należy pomijać:

- usługa musi zaczynać się tuż po wypisie ze szpitala, nie kilka tygodni później;
- centrum działania jest dom pacjenta, a nie urząd, poradnia ani szpital;
- rolą Organizatora jest koordynacja i edukacja opiekunów, a nie zastępowanie całej opieki długoterminowej;
- pierwsza wizyta musi być realną diagnozą bio-psycho-społeczną, a nie krótkim wywiadem telefonicznym;
- usługa ma zmniejszać chaos po wypisie: kto pomaga, czego pilnować, gdzie dzwonić, co zrobić dziś, co w najbliższym tygodniu;
- model powinien być oparty na szybkim uruchomieniu istniejących lokalnych zasobów, a nie budowaniu nowej struktury organizacyjnej;

- bardzo ważnym elementem jest praca z rodziną i opiekunami naturalnymi - ich przeciążenie często decyduje o powodzeniu lub porażce opieki domowej.

Ważne ostrzeżenie dla podmiotu wdrażającego:

Nie należy robić z tej innowacji ogólnej "opieki nad seniorami" ani dopisywać jej do zwykłych usług opiekuńczych. Istotą innowacji jest szybkie, domowe i koordynujące przejście między szpitalem a codziennym funkcjonowaniem pacjenta w domu.

## **2. Jak przekształcić innowację w usługę społeczną**

Dla małej gminy w Małopolsce ta innowacja może być jedną z najbardziej praktycznych, bo odpowiada na częstą sytuację: senior lub osoba po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia wraca ze szpitala, rodzina jest przestraszona, nie wie jak pielęgnować, gdzie załatwić łóżko, materac, zlecenia, opiekę, transport, wizytę POZ, a pracownik socjalny dowiaduje się o problemie dopiero wtedy, gdy kryzys już narasta.

Usługa powinna działać jako lokalny pomost między szpitalem a domem:

- szpital lub rodzina zgłasza osobę po wypisie;
- OPS/CUS/inny podmiot uruchamia procedurę;
- Organizator odwiedza pacjenta w domu;
- ocenia stan osoby i możliwości rodziny;
- przekazuje rodzinie praktyczne instrukcje;
- ustala indywidualny plan wsparcia;
- wskazuje, które sprawy wymagają kontaktu z POZ, pielęgniarką środowiskową, OPS/CUS, rehabilitacją, wypożyczalnią sprzętu, świadczeniami lub usługami opiekuńczymi;
- pomaga rodzinie uporządkować pierwsze dni po hospitalizacji;
- wraca z wizytą weryfikującą albo pozostaje dostępny telefonicznie w określonym zakresie.

W wielu małych gminach część infrastruktury już istnieje:

- opiekunki środowiskowe;
- usługi opiekuńcze;
- pracownicy socjalni koordynujący teren;
- spółdzielnie socjalne świadczące usługi opiekuńcze;
- lokalne sieci sąsiedzkie;
- parafie, wolontariusze i organizacje senioralne.

Dlatego wdrożenie tej innowacji powinno przede wszystkim uporządkować i przyspieszyć działanie tego, co już funkcjonuje, zamiast budować całkowicie nowy system.

To podejście jest zgodne z międzynarodową logiką Home First / Discharge to Assess: pacjent, który nie wymaga już łóżka szpitalnego, powinien jak najszybciej wrócić do domu lub środowiska lokalnego, a pogłębiona ocena długoterminowych potrzeb powinna odbywać się w realnym miejscu życia, nie w szpitalu.

Dla podmiotu wdrażającego sedno jest proste: nie tworzymy alternatywy dla szpitala ani POZ. Tworzymy brakujące ogniwo organizacyjne po wypisie.

### **3. Mapa wdrożenia usługi - krok po kroku**

#### **Etap przygotowania usługi - do 6 miesięcy**

##### **1) Wybrać lokalny punkt wejścia do usługi**

Największym ryzykiem jest brak zgłoszeń albo zgłoszenia zbyt późne. Dlatego w pierwszych miesiącach trzeba ustalić, skąd podmiot wdrażający będzie wiedział, że pacjent wraca do domu.

Możliwe źródła zgłoszeń:

- szpital powiatowy lub oddział, z którego najczęściej wracają seniorzy;
- pielęgniarki środowiskowe i POZ;
- rodzina pacjenta;
- pracownicy socjalni;
- sołtysi, opiekunki środowiskowe, asystenci rodziny;
- PCPR lub lokalne organizacje senioralne;
- hospicja domowe;
- organizacje pacjenckie.

Kluczowe jest szybkie uzyskanie informacji o wypisie. W praktyce często problemem nie jest brak usług, ale to, że gmina dowiaduje się o sytuacji zbyt późno - kiedy rodzina jest już przeciążona albo senior trafia ponownie do szpitala.

##### **2) Zawrzeć proste porozumienie ze szpitalem lub POZ**

Opis innowacji jasno wskazuje, że współpraca ze szpitalem jest warunkiem uniknięcia przestoju komunikacyjnych.

Nie musi to być od razu skomplikowana umowa. Na start wystarczy uzgodnić:

- kto może zgłosić pacjenta;
- jakie minimum informacji przekazuje;

- kiedy następuje zgłoszenie;
- kto kontaktuje się z rodziną;
- jak chronione są dane;
- co zrobić, gdy pacjent nie wyrazi zgody.

Warto szczególnie doprecyzować:

- jak szybko po decyzji o wypisie przekazywana jest informacja do podmiotu realizującego usługę;
- kto i w jaki sposób wstępnie ocenia, czy pacjent oraz jego bliscy będą potrzebowali dodatkowego wsparcia organizacyjnego lub opiekuńczego po powrocie do domu;
- kto jako pierwszy kontaktuje się z pacjentem lub rodziną po zgłoszeniu.

### **3) Ustalić, kto pełni funkcję Organizatora**

Istota innowacji zakłada, że funkcję Organizatora pełni pielęgniarzka opieki długoterminowej. W praktyce kluczowe jest jednak zachowanie równowagi między jakością wsparcia a realnymi możliwościami kadrowymi podmiotu wdrażającego.

Możliwe rozwiązania:

- podmiot realizujący usługę zleca realizację części działań pielęgniarce lub podmiotowi medycznemu;
- usługa realizowana jest we współpracy z POZ, pielęgniarzką opieką długoterminową lub innym podmiotem świadczącym usługi zdrowotne;
- część działań wspierających wykonują istniejące opiekunki środowiskowe lub osoby świadczące usługi opiekuńcze;
- działania opiekuńcze i wspierające realizowane są przy współpracy z organizacją pozarządową lub spółdzielnią socjalną.

Nie wszystkie działania wymagają wysoko wyspecjalizowanego personelu medycznego. W praktyce dobrze sprawdzają się:

- przeszkolone opiekunki środowiskowe;
- osoby z doświadczeniem opiekuńczym;
- osoby świadczące usługi opiekuńcze w środowisku lokalnym;
- lokalne opiekunki współpracujące wcześniej z podmiotem realizującym usługę.

W ramach grantu możliwe jest również przygotowanie i przeszkolenie osób realizujących usługę w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań wspierających, organizacyjnych i opiekuńczych związanych z wdrożeniem innowacji.

W małych gminach trudnością może być pozyskanie nowych osób do realizacji usługi, szczególnie jeśli działania mają charakter krótkoterminowy lub wymagają szybkiego uruchomienia wsparcia po wypisie ze szpitala. Dlatego warto:

- budować model dłuższej współpracy z osobami świadczącymi wsparcie środowiskowe;
- szkolić lokalne osoby w zakresie podstaw organizacji opieki domowej i wsparcia rodziny po hospitalizacji;
- wykorzystywać istniejące usługi i zasoby funkcjonujące w środowisku lokalnym;
- rozwijać lokalną sieć osób wspierających rodziny w pierwszych dniach po wypisie pacjenta do domu.

Warto pamiętać, że Organizator kompleksowej opieki nie zastępuje usług opiekuńczych ani personelu medycznego. Istotą innowacji jest przede wszystkim instruktażowe, organizacyjne i koordynujące wsparcie rodziny w bezpiecznym przejściu pacjenta ze szpitala do funkcjonowania w domu.

#### **4) Przygotować prostą ścieżkę działania**

Minimalna ścieżka:

- zgłoszenie pacjenta;
- kontakt z rodziną lub opiekunem;
- szybkie ustalenie, czy pacjent i jego bliscy będą potrzebowali dodatkowego wsparcia po powrocie do domu;
- pierwsza wizyta do 24 godzin od zgłoszenia;
- diagnoza sytuacji zdrowotnej, opiekuńczej i organizacyjnej;
- przygotowanie planu wsparcia;
- przekazanie rodzinie praktycznych instrukcji i informacji;
- kontakt z podmiotami i osobami zaangażowanymi w dalsze wsparcie pacjenta;
- uruchomienie działań wspierających odpowiadających na najpilniejsze potrzeby pacjenta i opiekunów;
- wizyta lub kontakt weryfikujący;
- decyzja o dalszych formach wsparcia i przekazaniu pacjenta do odpowiednich usług funkcjonujących lokalnie.

Warto jasno zaplanować:

- kto odpowiada za pierwszy kontakt;
- kto podejmuje decyzję o objęciu usługą;

- kto uruchamia kolejne elementy wsparcia;
- jakie są maksymalne czasy reakcji.

## **5) Przygotować narzędzia pracy**

Opis innowacji wskazuje gotowe narzędzia:

- Kwestionariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego;
- Kartę Wsparcia Pacjenta;
- Kartę wizyt weryfikująco-wspierających;
- procedurę interwencji w 24 godziny;
- broszury edukacyjne;
- konspekty szkoleń.

Podmiot wdrażający nie powinien tworzyć dokumentacji od zera. Powinien ją dostosować do lokalnej procedury.

Warto dodać:

- prostą checklistę "co trzeba uruchomić w pierwszych 72 godzinach";
- listę lokalnych usług i kontaktów;
- krótką kartę dla opiekunki środowiskowej lub sąsiada wspierającego rodzinę;
- prostą instrukcję dla rodziny: "co robić dziś, jutro i w tym tygodniu".

## **6) Przeszkolić minimum osób**

Nie szkolić całego urzędu/podmiotu. Wystarczy mały krąg:

- 1 osoba organizacyjna w podmiocie wdrażającym;
- 1-2 pracowników socjalnych;
- Organizator;
- osoba kontaktowa w POZ/szpitalu;
- opiekunki środowiskowe;
- ewentualnie lokalne osoby wspierające po krótkim szkoleniu praktycznym.

W praktyce bardzo wartościowe może być stworzenie lokalnego programu:

- szkolenia sąsiadów i opiekunów środowiskowych;
- krótkiego wdrożenia praktycznego;
- budowy lokalnej sieci osób gotowych do prostego wsparcia po wypisie.

Warto pamiętać, że osoby realizujące usługę również potrzebują wsparcia. Regularne konsultacje, wymiana doświadczeń i prosta superwizja pomagają ograniczać przeciążenie emocjonalne personelu.

## 7) Przygotować pakiet informacji dla rodziny

Rodzina po wypisie nie potrzebuje broszury o systemie. Potrzebuje krótkiej odpowiedzi:

- co zrobić dziś;
- co obserwować;
- kiedy dzwonić do lekarza;
- jak zapobiegać odleżynom;
- jak bezpiecznie przenosić;
- gdzie zgłosić się po sprzęt;
- kto w gminie pomaga;
- jaki jest następny krok.

Pierwsza wizyta powinna obejmować także praktyczne treningi:

- opiekuńczo-pielęgnacyjne;
- organizacji przestrzeni chorego;
- ergonomii opieki;
- profilaktyki zakażeń;
- bezpiecznego korzystania ze sprzętu.

Często drobne zmiany:

- ustawienie łóżka,
- usunięcie dywanów,
- montaż uchwytów,
- reorganizacja pokoju,

realnie zmniejszają ryzyko kolejnych kryzysów i odciążają opiekunów.

Ważne: średni czas pierwszej wizyty to około 3,5 godziny i nie należy sztucznie skracać tego procesu.

### **Etap świadczenia usługi - minimum 12 miesięcy**

W okresie świadczenia usługa powinna mieć rytm:

- bieżące przyjmowanie zgłoszeń;
- pierwsza wizyta domowa;
- plan wsparcia;
- edukacja rodziny;
- krótkie działania koordynujące;

- kontakt z osobami i podmiotami wspierającymi pacjenta w środowisku lokalnym;
- wizyty weryfikujące;
- przekazywanie rodzinie informacji o dostępnych formach dalszego wsparcia;
- monitorowanie efektów.

Warto pamiętać, że istotą innowacji nie jest finansowanie standardowych usług opiekuńczych, ale stworzenie sprawnego modelu organizacji wsparcia po hospitalizacji. Podmiot wdrażający może jednak wzbogacić usługę o dodatkowe działania odpowiadające na potrzeby pacjenta i rodziny, np. instruktaż opiekuńczy, działania edukacyjne, wsparcie informacyjne, organizację sprzętu, działania środowiskowe lub krótkoterminowe wsparcie koordynacyjne.

#### **4. Co jest obowiązkowe, a co można rozszerzać**

##### **Elementy konieczne**

Bez tych elementów usługa przestaje być tą innowacją:

- pacjent wracający ze szpitala do domu;
- szybka interwencja - najlepiej w pierwszej dobie od zgłoszenia;
- wizyta w miejscu zamieszkania;
- Organizator z kompetencjami opiekuńczymi/koordynacyjnymi;
- diagnoza sytuacji pacjenta i opiekuna;
- indywidualny plan wsparcia;
- edukacja opiekuna naturalnego;
- połączenie zasobów: szpital/POZ/OPS/CUS/inny podmiot/rodzina;
- wizyty lub kontakt weryfikujący;
- praktyczny trening dla rodziny;
- wykorzystanie standaryzowanych narzędzi i formularzy.

##### **Elementy opcjonalne**

Można je dodać, jeżeli podmiot realizujący usługę posiada odpowiednie zasoby organizacyjne i partnerskie:

- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;
- szybka ścieżka informacji o dostępnych lokalnie formach wsparcia po wypisie ze szpitala;
- działania informacyjne i animujące lokalne wsparcie sąsiedzkie;
- wsparcie organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjalnej;

- konsultacja dietetyczna;
- konsultacja fizjoterapeutyczna;
- wsparcie psychologiczne dla opiekuna;
- teleopieka lub opaska bezpieczeństwa;
- grupa edukacyjna lub wsparcia dla opiekunów rodzinnych;
- lista lokalnych dostawców usług i sprzętu;
- prosty telefon wsparcia dla rodzin;
- superwizja i wsparcie dla personelu realizującego usługę.

## 5. Jak poradzić sobie z typowymi barierami

### Bariera 1: "Nie mamy pielęgniarki w naszych zasobach"

Nie trzeba jej zatrudniać na etat. Można:

- kupić usługę;
- współpracować z POZ;
- korzystać z pielęgniarki środowiskowej;
- budować model mieszany z udziałem opiekunek środowiskowych.

Najważniejsze jest szybkie uruchomienie wsparcia, a nie stworzenie idealnej struktury kadrowej.

### Bariera 2: "Nie ma ludzi do pracy"

To jedna z najważniejszych barier wdrożeniowych.

W małych gminach:

- osoby z doświadczeniem opiekuńczym są przeciążone;
- niskie stawki odstrasza;
- krótkie projekty nie przyciągają nowych osób.

Dlatego warto:

- budować dłuższą współpracę;
- szkolić lokalne osoby;
- wykorzystywać istniejące kadry;
- rozwijać sieć opiekunów środowiskowych;
- rozważyć model międzygminny.

### Bariera 3: "To dubluje działania ochrony zdrowia"

Nie.

Model nie zastępuje leczenia ani pielęgniarstwa długoterminowego. Wypełnia lukę między wypisem a uruchomieniem dalszych świadczeń.

Jego celem jest ograniczenie:

- chaosu po wypisie;
- przeciążenia rodzin;
- błędów opiekuńczych;
- rehospitalizacji;
- wydłużonych pobytów szpitalnych.

#### **Bariera 4: "Rodziny nie będą chciały współpracować"**

W praktyce większość rodzin nie odrzuca pomocy - problemem jest raczej poczucie chaosu, wstydu i przeciążenia.

Kluczowe jest:

- prosty język;
- konkretne instrukcje;
- wsparcie w domu;
- spokojna komunikacja;
- pokazanie, że Organizator pomaga rodzinie odzyskać kontrolę nad sytuacją.

#### **Bariera 5: "To będzie za drogie"**

Najdroższe są:

- kolejne hospitalizacje;
- przeciążenie rodzin;
- szybka utrata samodzielności pacjenta;
- konieczność całodobowej opieki instytucjonalnej.

Ta innowacja działa przede wszystkim jako mechanizm ograniczania kryzysów.

## **6. Działania wspierające wdrożenie innowacji**

Rekomendowane działania:

- lokalna baza sprzętu rehabilitacyjnego;
- działania edukacyjne dla opiekunów rodzinnych dotyczące organizacji opieki domowej po hospitalizacji;

- lista lokalnych usług i kontaktów;
- współpraca z hospicjami domowymi;
- współpraca z parafiami i wolontariatem;
- grupy wsparcia dla opiekunów;
- działania informacyjne i animujące lokalne wsparcie sąsiedzkie;
- warsztaty ergonomii opieki;
- edukacja dotycząca profilaktyki upadków;
- współpraca z UTW i klubami seniora;
- współpraca z podmiotami świadczącymi usługi specjalistyczne.

## **7. Jak wykorzystać wdrożenie do trwałej zmiany lokalnej**

Po grancie mogą zostać:

- lokalna procedura szybkiego wsparcia po hospitalizacji;
- sieć współpracy OPS/CUS/inny podmiot wdrażający-POZ-szpital;
- baza lokalnych usług opiekuńczych;
- lokalna sieć opiekunów środowiskowych;
- standard współpracy między sektorem zdrowia a pomocą społeczną;
- doświadczenie w organizowaniu opieki środowiskowej;
- większa gotowość mieszkańców do opieki domowej;
- ograniczenie rehospitalizacji i kryzysów rodzinnych.

Najważniejsza trwała zmiana:

gmina/podmiot wdrażający zaczyna działać szybciej i bardziej koordynacyjnie w pierwszych dniach po hospitalizacji mieszkańca.

## **8. Możliwe kierunki rozwoju usługi lokalnie**

Po wdrożeniu pilotażowym można rozwijać usługę w kilku kierunkach:

- lokalny navigator opieki senioralnej;
- model międzygminny;
- mobilny zespół opieki przejściowej;
- centrum wsparcia opiekunów rodzinnych;
- usługi sąsiedzkie po hospitalizacji;
- teleopieka;

- wsparcie osób po udarze;
- wsparcie osób z demencją;
- lokalna wypożyczalnia sprzętu;
- program profilaktyki przeciążeń opiekunów;
- rozwój mieszkań wspieranych dla seniorów.

## 9. Szybka checklista dla Grantobiorcy przed zaplanowaniem wdrożenia

- Czy zachowujemy istotę innowacji: szybkie przejęcie pacjenta po wypisie?
- Czy pierwsza wizyta odbywa się realnie w domu?
- Czy usługa pomaga uporządkować sytuację pacjenta i rodziny po hospitalizacji?
- Czy wiadomo, skąd będą trafiać zgłoszenia?
- Czy podmiot realizujący usługę ma ustaloną współpracę ze szpitalem lub POZ?
- Czy wymagania kadrowe zostały dopasowane do realnych możliwości organizacyjnych i lokalnego rynku pracy?
- Czy usługa wykorzystuje istniejące lokalnie zasoby i formy wsparcia, zamiast tworzyć równoległy system usług?
- Czy rodzina dostaje praktyczne instrukcje i informacje o możliwościach dalszego wsparcia?
- Czy Organizator ma możliwość kontaktu weryfikującego po pierwszej wizycie?

# ORGANIZATOR KOMPLEKSOWEJ OPIEKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

## INNOWACJA W POSTACI USŁUGI SPOŁECZNEJ



### CO?

NA CZYM POLEGA?



**Szybkie przejęcie pacjenta po wypisie ze szpitala i wsparcie rodziny w pierwszych dniach w domu.**

Organizator w ciągu 24 h odwiedza pacjenta w domu, ocenia sytuację, uczy rodzinę opieki i łączy dostępne lokalne zasoby w jeden plan wsparcia.

Celem jest bezpieczeństwo pacjenta, spokój rodziny i jak najdłuższe pozostanie w domu.

### KLUCZ:

- ✓ Start usługi tuż po wypisie – w ciągu 24 h
- ✓ Dom pacjenta jest centrum działania
- ✓ Koordynacja i edukacja – nie zastępowanie opieki medycznej
- ✓ Porządkowanie pierwszych dni po hospitalizacji
- ✓ Współpraca: szpital, POZ, OPS/CUS, rodzina, usługi lokalne
- ✓ Praca z rodziną i opiekunami naturalnymi



### JAK?

ETAPY WDROŻENIA  
USŁUGI

1

#### ZGŁOSZENIE PO WYPISIE



Szpital / POZ / rodzina / OPS  
przekazuje informację  
o pacjencie wracającym  
do domu.

2

#### SZYBKI KONTAKT I WIZYTA W DOMU



Organizator dociera do domu  
w ciągu 24 h i ocenia sytuację  
pacjenta oraz możliwości  
rodziny.

3

#### PLAN PIERWSZYCH DZIAŁAŃ



Ustala plan wsparcia,  
przekazuje instrukcje opieki,  
listę najważniejszych działań  
i kontakty.

4

#### URUCHOMIENIE DZIAŁAŃ WSPARCIA



Włączenie dostępnych lokalnych  
zasobów i wsparcia:  
POZ, opieka środowiskowa,  
rehabilitacja, pomoc sąsiedzka,  
sprzęt, świadczenia i inne.

5

#### WERYFIKACJA I DALSZE WSPARCIE



Sprawdzenie sytuacji,  
korekta planu i dalsze  
wsparcie telefoniczne  
lub wizytą.



### PO CO?

GŁÓWNA KORZYŚĆ  
DLA GMINY



Mniej chaosu  
po hospitalizacji



Mniejsze ryzyko  
powikłań i ponownych  
hospitalizacji



Większe bezpieczeństwo  
i komfort pacjenta  
w domu



Lepsze wykorzystanie  
istniejących usług  
i zasobów



Wspólne działanie  
szpitala – POZ – OPS/CUS/inny  
podmiot – rodzina – usługi lokalne



Rodzina wie,  
co robić.  
System działa  
wokół człowieka.



**To nie nowa instytucja – to brakujące 24–72 godziny bezpieczeństwa po wypisie ze szpitala.**

Szybki czas reakcji. Lepsza opieka w domu. Spokojniejsza rodzina. Skuteczniejsza pomoc.